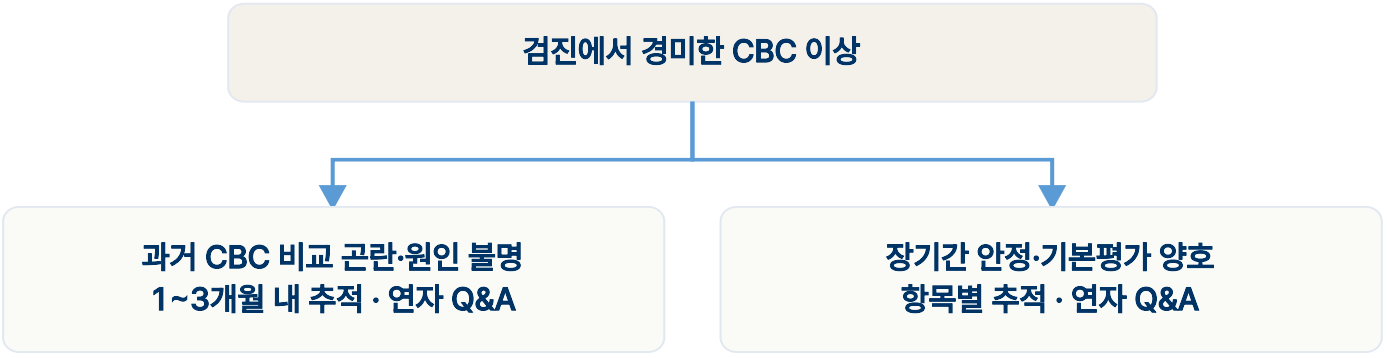
경미한 CBC 이상 과거 수치와 추세부터

이 카드의 추적 전략은 최은지 연자 Q&A 답변입니다



직접 문진이 어려운 검진 상황

이전 CBC와 비교하고, 위·대장내시경(GI bleeding), 복부 영상(간경화·비장비대), 갑상선기능(TFT)을 종합합니다. 이전 자료가 불충분하거나 원인이 불분명하면 1~3개월 내 추적이 현실적인 방법이라고 답했습니다.

경미한 빈혈 · 관찰과 의뢰

구분	진료 중 확인할 내용
추적 가능	다른 혈구·PBS·신기능 등 기본검사를 검토하고, 원인 없이 경한 빈혈이 비슷하게 장기간 유지되면 연 1~2회 추적.
평가 의뢰	수년에 걸쳐서라도 Hb가 서서히 감소하거나, 새로 발생·진행하면 혈액내과 평가 권유.
다른 혈구 동반	다른 계열의 혈구감소, 연령, 빈혈 추세를 함께 보고 골수검사 여부를 결정.

장기간 안정된 두 계열 감소 · 연자 Q&A 증례

15년 이상 비슷한 경미한 정구성 빈혈·백혈구감소는 급히 골수검사를 하지 않아도 될 가능성이 높다고 답했습니다. 간경화·비장비대·자가면역 소견(ANA 등)을 보고, 이상이 없으면 연 1~2회 추적이 가능하나 혈액내과 진료 경험이 없다면 한 번 권유할 수 있다고 설명했습니다.

본강 · 빠르게 의뢰할 소견

PBS의 blast·immature cell, 빠른 Hb 저하, 다른 혈구 이상, 원인 불명 고령·대구성 빈혈은 혈액내과 의뢰 소견입니다. TMA 의심은 응급 의뢰합니다.

Hb는 정상인데 MCV만 높을 때

최은지 연자 Q&A · 빈혈 없이도 원인과 혈구 추세를 봅니다

병력과 기본검사

구분	진료 중 확인할 내용
먼저 질문	음주와 약물: MTX, azathioprine, hydroxyurea, bactrim, 항경련제(AED) 등.
해당 병력 없을 때	PBS, reticulocyte, vitamin B12/folate 검사. 원인이 불분명하고 수치가 안정적이면 CBC를 추적해 cytopenia 발생을 관찰.
MCV 약 120 fL 증례	상당한 대구성이므로 평가가 필요하다고 답변. 위 항목에 간기능·갑상선기능 검사를 함께 제안.

MCV 101~105만으로 B12 부족으로 단정하지 않기

지속적인 MCV 상승에서는 약물력과 PBS·reticulocyte·B12/folate를 먼저 평가하도록 권유했습니다. 원인이 불분명해도 안정적이면 CBC를 추적하며 다른 혈구감소 발생을 봅니다.

빈혈이 동반되면 · 본강

구분	진료 중 확인할 내용
대구성 감별	B12/folate 결핍, 음주·간질환, 약물, 골수질환, 용혈.
범혈구감소	B12 결핍에 의한 거대적아구빈혈도 백혈구·혈소판 감소와 함께 나타날 수 있음.
고령·원인 불명	용혈·약물·B12/folate로 설명되지 않는 고령 대구성 빈혈은 골수질환을 감별하고 혈액내과 의뢰.

철분 치료 뒤 PBS 이상 · 연자 Q&A

IDA 증례에서 혈소판 수는 정상이고 일부 giant platelet만 보인 경우, 철분 투여 후 CBC가 회복된 시점에 PBS 추적을 권유했습니다.

백혈구·혈소판의 경미한 이상을 나누어 보기

최은지 연자 Q&A · 수치뿐 아니라 분획·PBS·진행 여부를 확인

백혈구 이상

구분	진료 중 확인할 내용
단독 백혈구감소	ANC, 최근 감염·약물, 일시적 또는 장기간 여부. PBS·reticulocyte·B12/folate·ANA·비장비대 등을 검토. 원인 없는 경미한 감소는 정기 추적, 진행하면 혈액내과 의뢰.
경미한 백혈구증가	스테로이드·흡연을 질문. 금연 후 감소하는 경우도 있음. Lymphocytosis·eosinophilia 등 특정 계열 증가면 혈액내과 의뢰.
Basophil ≥3% 질문	백혈구증가·혈소판증가 동반 여부를 확인. 다른 CBC가 정상이면 단기간 PBS 추적을 제안.
지속 Monocytosis	감염·염증, 항암 후 nadir 회복기 가능. 고령·원인 불명 빈혈·비장비대 또는 이유 없는 지속 증가면 CBC 추적 및 혈액내과 평가 고려.

혈소판감소와 장기 관찰

구분	진료 중 확인할 내용
경미한 감소	가성혈소판감소, 간질환, 약물 영향 평가. 뚜렷한 원인 없이 수년간 비슷하면 연 1~2회 CBC 추적.
65세 · 약 8만 증례	다른 혈구·PBS·분획이 정상이고 비장비대·간경화 등 원인이 없으면 ITP 가능성. 이 연령은 MDS도 드물게 발견. 새로 급격히 감소하면 혈액내과 평가.
치료 여부	출혈이 없고 안정적이면 수치만 올리기 위한 치료는 보통 필요하지 않다고 답변.

원인 불명 감소가 진행하면 의뢰

골수검사에 특이 소견이 없는 cytopenia는 ICUS, 관련 체세포 변이가 있으면 CCUS로 분류합니다. 일부 특정 변이에서 MDS 발생률 ≥60%가 보고된다고 설명했으며, 이 구분은 골수검사 뒤 가능합니다. CBC 악화 시 골수 재평가를 고려합니다.